CENTRE HOSPITALIER FICTIF DE LA PALOMBIÈRE
Pôle d'addictologie - CSAPA - 4, allée des Fictifs - 33800 BORDEAUX
Tél. 05 00 47 18 26 Finess 33 0 99994 1

HOURQUEBIE SYLVETTE Admission A1805220031
Née le 11/03/1972 (54 ans)
IPP 0072914386 UF 5340 - CSAPA
Pension de famille Les Ajoncs, 5 impasse des Fictifs, 33150 CENON

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Entretien téléphonique du 22/05/2018 (Urgence : Bas)

Validé par PEYRUSSE Maryse - IDE le 22/05/2018 à 11:20
Appel de Mme HOURQUEBIE Sylvette, 46 ans, adressée par son médecin traitant le Dr LAVERNY (Bègles), qui a faxé un courrier ce matin.
Demande "d'arrêter de boire pour de bon", parle d'un "dernier sevrage en 2016 qui n'a servi à rien". Boit environ 2 litres de vin par jour, "un peu de bière en plus quand il fait chaud". Tremblements le matin, a déjà "le verre du réveil".
Sous Xanax 0,25 mg 3 fois par jour prescrit par le Dr LAVERNY depuis "trois ans à peu près".
Vit à Bègles avec son compagnon, "lui aussi il boit". Problèmes de loyer, "on va peut-être me mettre dehors".
Elle pleure au téléphone, dit qu'elle n'en peut plus. Pas d'idées suicidaires exprimées quand je pose la question.
Tél : 06 58 21 47 93.
RDV médical donné le 29/05 à 14h avec le Dr ARRIBAT. Lui ai conseillé de ne surtout pas arrêter d'un coup d'ici là.

Observation médicale d'entrée du 29/05/2018 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBAT Ségolène - Psychiatre addictologue le 29/05/2018 à 19:12
Observations :
Motif : Mme HOURQUEBIE Sylvette, 46 ans, née le 11/03/1972 à Marmande, adressée par le Dr LAVERNY, médecin traitant à Bègles, pour prise en charge d'un trouble de l'usage de l'alcool. Demande personnelle : "un sevrage, mais un vrai, pas comme la dernière fois", et "ne pas finir comme mon père". Venue seule, à l'heure, tenue correcte mais négligée, odeur d'alcool discrète.

Histoire des consommations :
- Alcool : premier verre "vers 15 ans", à Marmande, "aux fêtes de village", premières ivresses dans la foulée. Usage festif et de fin de semaine pendant les années de travail et de mariage, "comme tout le monde là-bas". Usage quotidien installé au moment de la séparation d'avec son mari en 2006 ("c'est là que j'ai commencé le matin"). Perte de contrôle "depuis une dizaine d'années" : n'arrive plus à s'arrêter une fois le premier verre pris, boit seule, cache des bouteilles. Actuellement environ 2 L de vin rouge par jour (soit environ 20 UIA), parfois 2 ou 3 bières l'après-midi, premier verre au réveil vers 8h pour "arrêter les tremblements". Maximum : "3 litres certains jours l'hiver dernier". Pas d'épisode de convulsion ni de delirium rapporté. Dit n'avoir fait qu'un seul sevrage hospitalier, en 2016, "à la clinique du Lac" à Bordeaux, une semaine, rechute "au bout d'un mois, peut-être moins". Jamais de postcure. Plusieurs tentatives d'arrêt seule, "deux ou trois jours, pas plus", la dernière en février, interrompue par des tremblements et "une angoisse à hurler". Conséquences décrites : chutes à domicile (pas de fracture), oublis, disputes avec le compagnon, dette de loyer liée à l'argent "parti dans le vin". Boit surtout à la maison, seule le matin, avec Jeannot l'après-midi. Ne conduit pas (pas de voiture depuis 2014).
Questionnée sur ce qui l'a aidée en 2016 : "rien, je suis sortie un vendredi et le lundi j'avais rebu". Elle n'a jamais pris d'aide à l'abstinence (ni acamprosate ni baclofène), "on ne me l'a pas proposé".
- Benzodiazépines : alprazolam (Xanax) 0,5 mg matin, midi et soir, prescrit par le Dr LAVERNY depuis 2015 pour "l'angoisse" (ordonnance vue ce jour : 0,5 mg x3, et non 0,25 comme noté à l'appel). Dit le prendre comme prescrit, "parfois un de plus le soir". Pas d'achat hors prescription.
- Tabac : depuis l'âge de 15 ans, environ 25 cigarettes par jour actuellement. Pas de tentative d'arrêt.
- Cannabis : "quelques joints vers 20 ans", jamais régulier.
- Autres produits : nie formellement tout autre produit, "jamais de drogue dure, je ne suis pas comme ça". Jamais d'injection.

Antécédents psychiatriques : un épisode dépressif en 2016, traité par paroxétine par le Dr LAVERNY pendant "un an environ", arrêté seule. Actuellement tristesse de l'humeur depuis l'hiver, perte d'intérêt, sommeil haché, sentiment d'échec, culpabilité vis-à-vis de ses enfants. Pas d'idées suicidaires actives ; à la question des antécédents de geste suicidaire, répond "jamais, non". Pas d'hospitalisation en psychiatrie.

Antécédents somatiques : appendicectomie à 12 ans. Pas de traumatisme crânien ("non, jamais"). Pas de bilan hépatique récent selon elle. Pas de dépistage VIH/VHC fait. Pas d'allergie connue.

Antécédents familiaux : père ouvrier agricole, "gros buveur", décédé en 2003 d'une cirrhose. Mère Paulette, 78 ans, vit à

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Marmande, contacts téléphoniques "quand elle veut bien". Une sœur aînée, Ginette, à Marmande également, "on ne se parle plus trop".

Biographie : née et élevée à Marmande, dernière de deux filles. Enfance qu'elle décrit comme "normale, avec un père qui buvait" : pas de violence physique rapportée, des disputes "le samedi soir", une mère "qui tenait tout". Bonne élève jusqu'au collège, "forte en maths", orientée en lycée professionnel "parce qu'il fallait gagner sa vie vite". Bac pro de secrétariat en 1990. Parcours professionnel décrit de façon floue : "des petits boulots, de l'intérim, du secrétariat un peu partout", dernier emploi en 2014, au RSA depuis 2015. Mariée en 1994 avec M. Bruno TOULOUZE, deux enfants : Mélanie (23 ans) et Teddy (20 ans). Séparation en 2006 : "ça s'est mal fini, il buvait aussi", n'en dit pas plus. Les enfants "sont partis vivre chez leur père en 2009", quand "ça n'allait pas du tout". Plus de contact avec eux depuis 2014 environ ; c'est le sujet qui la fait pleurer.
Quand je lui demande ce qu'elle aimait faire, elle répond "les chiffres", puis change de sujet. Pas de loisirs actuels, sort peu, "la télé, le bar en bas".
Installée à Bègles depuis 2010, appartement en HLM (résidence Les Mouettes). Vit depuis 2017 avec M. Jean-Luc MAUBOURGUET, "Jeannot", qu'elle a rencontré "au bar", lui-même consommateur d'alcool important. Dette de loyer, commandement de quitter les lieux reçu en mars, "je n'ai pas osé ouvrir les courriers pendant des mois". Pas d'antécédent judiciaire. Pas de permis de conduire suspendu. Pas de mesure de protection.
Journée type : lever vers 7h, premier verre, courses "au plus près", télévision, sieste alcoolisée, "l'apéro avec Jeannot" à partir de 17h, coucher tôt. Ne mange qu'une fois par jour. Ne voit plus d'amis "d'avant".

Examen : TA 148/92, FC 96. Tremblements fins des extrémités. Pas d'astérixis. Discrète érythrose faciale. Hépatomégalie à 2 travers de doigt. Pas de signe neurologique focal, marche normale. Poids 58 kg.
Contact bon, adapté, un peu de honte. Thymie basse, pleurs, ralentissement modéré. Discours cohérent, pas d'élément délirant.

Échelles : AUDIT à faire avec l'IDE ; HAD anxiété 14, dépression 13.
Motivation : ambivalente mais réelle ; elle dit avoir "peur de mourir comme mon père, jaune, à 58 ans". Elle redoute surtout le regard des soignants et "qu'on fouille dans ma vie". Elle ne souhaite pas que le compagnon soit associé aux soins pour l'instant.

Synthèse : trouble de l'usage de l'alcool sévère (9 critères DSM-5 sur 11), consommation matinale, dépendance physique. Usage de benzodiazépines prescrites, à surveiller. Tabagisme à 25 cigarettes par jour. Épisode dépressif caractérisé d'intensité moyenne, en contexte d'alcoolisation, à réévaluer après sevrage. Grande précarité menaçante (expulsion).

Conclusions :
- Inscription pour sevrage hospitalier programmé (liste d'attente, délai 2 à 3 mois), à ne pas tenter seule.
- Thiamine 500 mg/j dès maintenant.
- Sertraline 50 mg le matin débutée ce jour, malgré l'alcool, devant l'intensité de la symptomatologie.
- Bilan : NFS, BHC, GGT, TP, CDT, sérologies VIH/VHB/VHC (refuse les sérologies pour l'instant), fibroscan.
- Pas de modification de l'alprazolam, à revoir au moment du sevrage.
- Orientation vers Mme BERGEZ (AS) pour la dette et la procédure d'expulsion.
- RDV IDE dans 1 semaine, médical dans 4 semaines.

Observation IDE du 05/06/2018 (Urgence : Bas)

Validé par PEYRUSSE Maryse - IDE le 05/06/2018 à 16:05
Mme HOURQUEBIE vient pour son bilan, à jeun "à part un verre ce matin pour pouvoir venir" (elle me le dit franchement, ce qui est bien). Prise de sang faite.
AUDIT à 33. Fagerström à 7.
Sertraline commencée depuis une semaine, un peu de nausées, "ça passe". Thiamine prise.
Elle me reparle de ses enfants, de sa fille surtout. Je n'insiste pas, elle a RDV avec Mme BERGEZ la semaine prochaine.
Résultats reçus à 17h : GGT 412, VGM 106, plaquettes 118 G/L, TP 74 %, ASAT 142, ALAT 61, CDT 5,8 %. Transmis au Dr ARRIBAT.

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Observation sociale du 12/06/2018 (Urgence : Bas)

Validé par BERGEZ Brigitte - Assistante sociale le 12/06/2018 à 12:40
Premier entretien social.
Mme HOURQUEBIE Sylvette, domiciliée résidence Les Mouettes, appt 23, 9 rue Ferdinand-Fictif, 33130 BÈGLES.
Locataire en titre seule (M. MAUBOURGUET hébergé, non déclaré).
Ressources : RSA (environ 550 €), pas d'APL depuis la dette. Dette locative 4 800 € (environ 14 mois). Commandement de quitter les lieux reçu en mars 2018, assignation devant le tribunal à venir. N'a jamais répondu au bailleur.
Parcours professionnel : "intérim, secrétariat", n'a "pas de papiers", ne sait pas dire combien d'années travaillées. Pas de droits chômage.
Démarches : saisine du FSL, demande de plan d'apurement auprès du bailleur, prise de contact avec l'ADIL pour l'audience. Dossier de surendettement à envisager.
Mme est d'accord pour que je contacte le bailleur. Prochain RDV dans 3 semaines.

Observation psychiatrique de suivi du 26/06/2018 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBAT Ségolène - Psychiatre addictologue le 26/06/2018 à 18:30
Observations :
Vue ce jour.
Consommation inchangée, "un peu moins le soir", 1,5 à 2 L/j. Sertraline 50 mg bien tolérée, humeur discrètement meilleure, "je pleure moins".
Fibroscan du 21/06 : 9,8 kPa, compatible avec une fibrose F2-F3. Biologie : GGT 412, VGM 106, thrombopénie à 118. Hépatopathie alcoolique, explications données.
Accepte enfin les sérologies.
Conclusions :
Sertraline 50 mg, thiamine 500 mg/j
Sérologies VIH, VHB, VHC
Sevrage hospitalier confirmé pour le 10/09
RDV 1 mois

Observation sociale du 03/07/2018 (Urgence : Bas)

Validé par BERGEZ Brigitte - Assistante sociale le 03/07/2018 à 11:05
RDV de suivi. Le bailleur accepte de suspendre la procédure si un plan d'apurement est respecté (100 €/mois en plus du loyer courant). Mme HOURQUEBIE signe, "je vais y arriver". Dossier FSL envoyé.
Elle n'a toujours pas trouvé de bulletins de salaire, "tout est resté chez mon ex".
Revoir en septembre, après l'hospitalisation.

Observation IDE du 17/07/2018 (Urgence : Bas)

Validé par PEYRUSSE Maryse - IDE le 17/07/2018 à 15:10
RDV non honoré. Appel sur le portable : répondeur. Message laissé.
Rappelle à 15h : est "chez sa mère à Marmande pour quelques jours", avait oublié. Va bien, "pareil". Nouveau RDV le 31/07.

Observation médicale d'entrée du 10/09/2018 (Urgence : Bas)

Validé par LAUSSU Thomas - Interne le 10/09/2018 à 17:55
Observations :
Entrée programmée dans l'unité de sevrage pour Mme HOURQUEBIE, 46 ans, suivie au CSAPA par le Dr ARIBAT.
Rappel : TUAL sévère, début de la consommation à 13 ans selon la patiente ce jour (15 ans dans l'observation d'entrée), consommation quotidienne depuis la séparation en 2006, un sevrage antérieur en 2016 (clinique du Lac). Pas d'ATCD de crise convulsive ni de DT. Tabac 25 cig/j. Alprazolam 0,5 mg x3 (MT). Sertraline 50 mg depuis fin mai. Hépatopathie alcoolique F2-F3 au fibroscan de juin.
Dernière consommation ce matin 9h, environ 1,5 L hier.
Examen : TA 156/98, FC 108, sueurs, tremblements, Cushman 8. Pas de syndrome confusionnel. Pas de signe de localisation.

Sérologies de juillet : VIH -, VHB vacciné, VHC -.
Conclusions :
Protocole diazépam (Cushman toutes les 4h), alprazolam arrêté et inclus dans le protocole
Thiamine 500 mg IV 3 jours
Sertraline poursuivie
Hydratation, vitamine PP, B6

Observation infirmière du 11/09/2018 (Urgence : Bas)

Validé automatiquement le 12/09/2018 à 06:00 par LABARCHEDE Michel
Nuit agitee jusqu'a 2h. Sueurs, tremblements, anxieuse. Cushman 9 a 23h -> diazepam 20 mg selon protocole. Cushman 5 a 3h.
Pas d'hallucinations, orientee. Demande a fumer x3, accompagnee sur le patio.
Dit qu'elle a "deja fait ca a Marm..." puis se reprend "non, a Bordeaux". A noter.
S'est endormie vers 3h30.

Observation médicale de suivi du 20/09/2018 (Urgence : Bas)

Validé par LAUSSU Thomas - Interne le 20/09/2018 à 11:40
Observations :
Sortie ce jour après 10 jours. Sevrage sans complication (Cushman max 9 la première nuit). Diazépam arrêté à J9.
Alprazolam non réintroduit, la patiente est d'accord ("on verra si je tiens").
Craving important. Introduction du baclofène 10 mg x3, titration en ambulatoire.
Échographie hépatique : hépatomégalie stéatosique, pas de nodule.
Conclusions :
Ordonnance de sortie : baclofène 10 mg x3, sertraline 50 mg, thiamine 250 mg/j
RDV Dr ARRIBAT le 16/10

Observation psychiatrique de suivi du 16/10/2018 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBAT Ségolène - Psychiatre addictologue le 16/10/2018 à 18:05
Observations :
Vue ce jour.
Rechute le 05/10, "Jeannot avait ramené un cubi", reprise quotidienne, environ 1 L/j. Honte, mais revenue d'elle-même.
Baclofène pris à 30 mg/j, pas de somnolence. Le Dr LAVERNY a represcrit l'alprazolam 0,5 mg x3 "parce que je dormais plus".
Humeur stable, sertraline poursuivie.
Audience d'expulsion fixée au 04/12.
Conclusions :
Titration du baclofène jusqu'à 60 mg/j (20 mg x3)
Appel au Dr LAVERNY : ne pas augmenter l'alprazolam
RDV 1 mois

Observation ELSA du 20/11/2018 (Urgence : Bas)

Validé par HONTANX Cédric - IDE ELSA le 20/11/2018 à 10:15
Appel UHCD. Pte HOURQUEBIE vue a l'UHCD.
Amenee par les pompiers le 18/11 au soir : crise convulsive generalisee devant son compagnon, a domicile, recup en 10 min. Morsure de langue.
Contexte : arret brutal de l'OH depuis le 16/11 "plus d'argent" + plus de Xanax depuis 4-5 jours (ordonnance pas renouvelee). Baclofene pris irregulierement.
TDM cerebrale aux urgences : pas de lesion aigue. Alcoolemie nulle a l'arrivee.
Diazepam 10 mg x4 aux urgences. Cushman 4 ce matin.
Propose hospit en addicto : refuse, "Jeannot est tout seul".
Sortie contre avis medical ce jour avec ordonnance diazepam 5 jours (Dr urgences) + info CSAPA.
RDV pris Dr ARRIBAT le 27/11.

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Observation psychiatrique de suivi du 27/11/2018 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBAT Ségolène - Psychiatre addictologue le 27/11/2018 à 17:45

Observations :
Vue ce jour avec M. MAUBOURGUET, à sa demande.
Crise convulsive généralisée de sevrage le 18/11 (alcool + arrêt de l'alprazolam), sortie de l'UHCD contre avis (cf. ELSA).
A repris l'alcool dès le 22/11, environ 1 L/j, "pour ne pas refaire une crise".
Information sur le risque de nouvelle crise ou de delirium en cas d'arrêt brutal. Baclofène 60 mg/j pris "presque tous les jours". Alprazolam 0,5 mg x3 représcrit par le MT.
Humeur : "je vais perdre l'appartement". Audience reportée au 18/12.
Conclusions :
Pas de sevrage seule : consigne écrite remise
Nouvelle inscription en sevrage hospitalier dès que possible
Baclofène 60 mg, sertraline 50 mg, thiamine
RDV 3 semaines

Entretien téléphonique du 04/12/2018 (Urgence : Bas)

Validé par PEYRUSSE Maryse - IDE le 04/12/2018 à 14:40

Appel du Dr LAVERNY, médecin traitant : il a bien reçu le courrier du Dr ARRIBAT. Il continue l'alprazolam 0,5 mg x3 "pour éviter une nouvelle crise", sans augmenter, ordonnance de 14 jours. Il a appris que l'audience était reportée.
Transmis au Dr ARRIBAT.

Observation IDE du 15/01/2019 (Urgence : Bas)

Validé par PEYRUSSE Maryse - IDE le 15/01/2019 à 10:30

Passage rapide pour l'ordonnance de baclofène (le Dr ARRIBAT l'avait laissée au secrétariat). Mme HOURQUEBIE dit que "ça va à peu près", consommation "pareille". Pas de nouvelle crise.
Me demande si je peux appeler le bailleur pour elle, je lui rappelle que c'est Mme BERGEZ qui suit ça et je lui donne un RDV.
Pas le temps pour un vrai entretien, elle attendait Jeannot dehors.

Observation IDE du 12/03/2019 (Urgence : Bas)

Validé par PEYRUSSE Maryse - IDE le 12/03/2019 à 09:45

Passage pour le renouvellement du baclofène 60 mg et de la sertraline. Mme HOURQUEBIE est pressée, "on a des cartons à faire". Pas d'entretien possible. Je lui rappelle le RDV avec Mme BERGEZ du 19/03.

Observation sociale du 19/03/2019 (Urgence : Bas)

Validé par BERGEZ Brigitte - Assistante sociale le 19/03/2019 à 14:50

Point sur la procédure d'expulsion.
Jugement du 18/12/2018 : résiliation du bail et expulsion ordonnée, sans délai supplémentaire. Le FSL a été refusé (dette trop ancienne, pas de reprise du paiement du loyer courant). Concours de la force publique accordé par la préfecture, expulsion possible dès la fin de la trêve hivernale (31/03).
Mme HOURQUEBIE est sidérée, "je pensais qu'ils allaient attendre". Le couple ne veut pas être séparé : refuse les places 115 "femmes seules".
Demande SIAO déposée (hébergement couple). Je lui donne l'adresse du CAARUD et de l'accueil de jour. Revoir avant la date.

Observation psychiatrique de suivi du 23/04/2019 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBAT Ségolène - Psychiatre addictologue le 23/04/2019 à 16:20

Observations :
Venue sans RDV, accompagnée de M. MAUBOURGUET.
Expulsée le 16/04/2019 au matin, en présence de l'huissier et de la police. Dorment depuis chez un ami de Jeannot à Bordeaux, "dans le salon", "ça va pas durer".
A perdu ses médicaments et ses ordonnances dans le déménagement : plus de baclofène ni de sertraline depuis une

semaine, "de toute façon j'en voyais pas l'intérêt". Plus d'alprazolam non plus.
Alcool : environ 2 L/j, "c'est pire".
Pleure, épuisée. Pas d'idées suicidaires, "j'ai pas le temps pour ça".
Conclusions :
Represcription proposée : n'en veut pas pour l'instant, sauf la thiamine
Pas de sevrage dans ce contexte : réduction des risques, ne pas arrêter brutalement
Lien avec l'équipe mobile psychiatrie-précarité (EMPP) et le CAARUD demandé avec son accord
Recontacter Mme BERGEZ

Observation IDE du 04/06/2019 (Urgence : Bas)

Validé par PEYRUSSE Maryse - IDE le 04/06/2019 à 17:00
RDV non honoré.
Numéro de portable ne répond plus ("ce numéro n'est plus attribué").
Appel au CAARUD La Passerelle : la connaissent, elle passe "de temps en temps" avec son compagnon. Message laissé pour qu'elle rappelle le CSAPA.

Observation équipe mobile précarité du 09/07/2019 (Urgence : Bas)

Validé par SAUBADE Aurore - IDE EMPP le 09/07/2019 à 18:40
Rencontre lors de la maraude, quai de Paludate, avec M. MAUBOURGUET. Le couple dort sous une tente près de la gare Saint-Jean depuis "fin mai".
Mme HOURQUEBIE dit avoir été "expulsée en mars" et être passée "de canapé en canapé" avant la tente.
Alcool : vin en brique, "2 ou 3 litres à deux". Dit prendre "des Rivotril de la rue" depuis le printemps, "2 ou 3 par jour", pour dormir et "pas trembler", achetés autour de la gare. Plus de traitement prescrit.
Plaies infectées aux deux pieds (chaussures inadaptées) : soins faits, orientation PASS.
Humeur triste, sommeil très mauvais, peur la nuit ("on se fait voler"). Pas d'idée suicidaire exprimée.
Lui ai rappelé que le CSAPA l'attend. Accepte d'être revue par l'EMPP chaque semaine. Domiciliation à faire au CAARUD.
M. MAUBOURGUET, présent, parle beaucoup à sa place ; quand il s'éloigne, elle dit "c'est grâce à lui que je suis pas morte dehors". Pas d'élément évoquant des violences dans le couple à ce stade, question posée seule à seule.

Transmission CAARUD du 17/09/2019 (Urgence : Bas)

Validé par GUIRAUD Mathieu - Éducateur spécialisé le 17/09/2019 à 11:25
Transmission de Mme Kenza DUTHIL, éducatrice au CAARUD La Passerelle, avec l'accord de Mme HOURQUEBIE :
- fréquente le CAARUD depuis juin, deux à trois fois par semaine (douches, laverie, café), domiciliation postale faite au CAARUD en août ;
- prend du matériel de réduction des risques "pour son compagnon" (embouts, roule-ta-paille) ;
- demande des préservatifs ;
- reste fragile, "beaucoup d'alcool dès le matin".

Je l'ai vue ensuite au CSAPA (RDV pris par le CAARUD) : souhaite garder un lien "mais pas de sevrage dehors, c'est trop dur". Accord pour un RDV éducatif mensuel et un RDV avec le Dr ARRIBAT à l'automne.

Observation équipe mobile précarité du 05/11/2019 (Urgence : Bas)

Validé par SAUBADE Aurore - IDE EMPP le 05/11/2019 à 19:05
Maraude. Mme HOURQUEBIE et M. MAUBOURGUET ont déplacé la tente sous le pont, côté Bastide.
Amaigrie (elle estime avoir perdu "5 ou 6 kilos"). Plusieurs pipes à crack et des cuillères dans la tente : Mme dit que c'est "à Jeannot", nie en consommer elle-même.
Alcool inchangé. Rivotril de rue "quand j'en trouve".
Toux grasse, pas de fièvre. Proposition d'accompagnement à la PASS : accepte pour jeudi.
Bien que fatiguée, a gardé de l'humour, parle de sa fille ("elle a 24 ans maintenant").

Observation équipe mobile précarité du 10/12/2019 (Urgence : Bas)

Validé par SAUBADE Aurore - IDE EMPP le 10/12/2019 à 20:10
Maraude par grand froid. Couple toujours sous le pont, couvertures de survie distribuées. Proposition de mise à l'abri 115

(gymnase, plan grand froid, couples acceptés) : refus de M. MAUBOURGUET, Mme suit.
Mme HOURQUEBIE tousse moins. Alcool "comme d'hab". Repasser jeudi.

Observation ELSA du 14/01/2020 (Urgence : Bas)

Validé par HONTANX Cédric - IDE ELSA le 14/01/2020 à 14:30
Appel du service de medecine (secteur 3). Pte HOURQUEBIE Sylvette, 47 ans.
Admise le 10/01 via SAMU : trouvee confuse dans la tente par son compagnon, agitee, hallucinations (insectes, "des gens dans la tente"), fievre 38,6, tachycardie 130. Pas bu depuis 4 jours "plus d'argent, il faisait trop froid pour faire la manche".
Delirium tremens -> rea 3 jours (diazepam IV, thiamine), transferee en medecine le 13/01.
Ce jour : orientee, critique partiellement, amnesie des 2 premiers jours.
Toxiques urinaires a l'entree : BZD +, cocaine +. Interrogee : reconnait "la galette" (crack) "quelques fois depuis Noel", fume "avec Jeannot", "pas tous les jours".
Info RDR crack donnee (pipes, embouts). Propose SSR addicto : reflechit.
Compagnon M. MAUBOURGUET passe tous les jours, reste dans le hall (alcoolise, calme). La pte s'inquiete pour lui "il va pas tenir sans moi".
Vu avec medecin du service : thiamine 500 mg x3 IV poursuivie, pas de BZD a la sortie (risque de mesusage avec le clonazepam de rue). Poids 47 kg, denutrition, dieteticienne passee.
Repasser jeudi.

Observation ELSA du 21/01/2020 (Urgence : Bas)

Validé par HONTANX Cédric - IDE ELSA le 21/01/2020 à 12:05
Revue avant sortie, prevue ce jour.
Refuse SSR : "je laisse pas Jeannot dehors en janvier".
Diazepam arrete hier. Thiamine 250 mg/j sur ordonnance.
Sortie vers la rue, avec l'accord du medecin du service. EMPP prevenue (Mme SAUBADE) + CSAPA.
RDV Dr ARRIBAT le 11/02 donne sur papier, avec le numero du CSAPA.

Observation psychiatrique de suivi du 11/02/2020 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBAT Ségolène - Psychiatre addictologue le 11/02/2020 à 17:35
Observations :
Venue, accompagnée par Mme SAUBADE (EMPP).
Hospitalisée du 10 au 21/01/2020 pour un delirium tremens (réanimation 3 jours) après un arrêt contraint de l'alcool.
Rappel : crise convulsive de sevrage en novembre 2018, sevrage hospitalier en septembre 2018 et en 2016.
Actuellement : alcool 1,5 L/j environ ; crack fumé "3 ou 4 fois par semaine", quand il y a de l'argent ; clonazépam de rue 2 à 4 mg/j. Tabac 20 à 30 cig/j "selon ce qu'on trouve".
Toujours à la rue, refuse le 115 sans son compagnon.
Humeur basse, anhédonie, "je survis". Pas d'idées suicidaires.
Conclusions :
Thiamine 250 mg/j
Information sur le risque de nouvel arrêt brutal (DT) : en cas de manque d'argent, venir au CSAPA ou aux urgences
Pas d'autre traitement souhaité pour l'instant
Travail avec l'EMPP pour un hébergement couple

Observation équipe mobile précarité du 05/05/2020 (Urgence : Bas)

Validé par SAUBADE Aurore - IDE EMPP le 05/05/2020 à 16:00
Visite à l'hôtel (dispositif 115, confinement) où le couple est hébergé depuis le 20/03.
Chambre propre, Mme HOURQUEBIE "a repris des couleurs". Alcool "un peu moins", entre 1 et 1,5 L/j, achète au supermarché d'à côté. Crack "presque tous les jours" depuis le confinement, payé avec "ce qu'on se débrouille". N'en dit pas plus.
Sommeil meilleur. Repas fournis.
Inquiétude pour la fin du dispositif (annoncée pour juin).
Prochain passage dans 15 jours.

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Observation équipe mobile précarité du 07/07/2020 (Urgence : Bas)

Validé par SAUBADE Aurore - IDE EMPP le 07/07/2020 à 19:30
Fin du dispositif hôtelier le 30/06 : le couple est retourné dans un squat à Bacalan, puis sous la tente. Pas de place 115 couple.
Mme HOURQUEBIE a maigri de nouveau, évasive sur l'argent. Crack quotidien reconnu.
Lui rappelle les horaires du CAARUD et le numéro du CSAPA.

Transmission CAARUD du 15/09/2020 (Urgence : Bas)

Validé par GUIRAUD Mathieu - Éducateur spécialisé le 15/09/2020 à 10:50
Transmission de Mme DUTHIL (CAARUD La Passerelle) :
- le couple est de nouveau à la rue depuis la fermeture de l'hôtel fin juin, squat puis tente à Bacalan ;
- Mme HOURQUEBIE a été placée en garde à vue fin août (24 h) pour un vol de bouteilles dans un supermarché, rappel à la loi ;
- consommation de crack quotidienne, brûlures aux lèvres et aux doigts, perte de poids ;
- prend des kits base (pipes) à chaque passage ;
Appel à Mme HOURQUEBIE via le téléphone du CAARUD : RDV donné avec moi et avec le Dr ARRIBAT en octobre.

Observation IDE du 13/10/2020 (Urgence : Bas)

Validé par PEYRUSSE Maryse - IDE le 13/10/2020 à 16:45
RDV non honoré avec le Dr ARRIBAT (ni avec M. GUIRAUD ce matin).
Appel au CAARUD : pas vue depuis 10 jours. Message laissé à Mme DUTHIL.

Observation équipe mobile précarité du 26/01/2021 (Urgence : Bas)

Validé par SAUBADE Aurore - IDE EMPP le 26/01/2021 à 18:20
Maraude, puis accompagnement de Mme HOURQUEBIE à l'accueil de jour.
M. MAUBOURGUET est décédé le 19/01/2021 au matin dans la tente, à Bacalan. Mme HOURQUEBIE l'a trouvé "froid" en se réveillant. SAMU, police. D'après ce qu'elle a compris, "arrêt cardiaque", autopsie demandée, résultats non connus. Elle n'a pas pu voir le corps depuis, la famille de M. MAUBOURGUET (une sœur à Pau) s'occupe des obsèques et "ne veut pas d'elle".
Mme est effondrée, n'a quasiment pas dormi depuis une semaine, dort dans un hall d'immeuble. Boit "tout ce que je trouve", fume le crack "pour pas penser", dit en avoir "pris plus que jamais". Idées de mort exprimées : "je devrais être partie avec lui", sans scénario précis, critique partielle ("je sais que c'est l'alcool qui parle").
Évaluation avec le psychiatre de l'EMPP par téléphone : pas d'indication d'hospitalisation sous contrainte, refus d'une hospitalisation libre. Mise à l'abri ce soir à la halte de nuit femmes (accord du 115, place réservée). Elle a d'abord refusé, puis accepté "pour une nuit", à condition de pouvoir garder le sac de Jeannot avec elle.
Pas de traitement en cours. Elle a perdu ses papiers d'identité dans l'intervention des secours ; le CAARUD l'aidera pour la déclaration de perte.
RDV en urgence au CSAPA pris pour le 02/02 avec le Dr ARRIBAT, je l'accompagnerai. Passage quotidien de l'équipe d'ici là.

Observation psychiatrique de suivi du 02/02/2021 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBAT Ségolène - Psychiatre addictologue le 02/02/2021 à 18:50
Observations :
Vue ce jour, accompagnée par Mme SAUBADE (EMPP).
Décès de son compagnon, M. MAUBOURGUET, le 19/01/2021 dans leur tente. Mme HOURQUEBIE n'a pas été invitée aux obsèques.
Tableau d'épisode dépressif caractérisé sévère : tristesse permanente, pleurs, anhédonie, insomnie quasi totale, culpabilité ("j'aurais dû le réveiller"), idées de mort quotidiennes. Pas de scénario arrêté, "je n'ai pas le courage". Facteur de protection évoqué : "ma fille, si un jour elle veut me revoir". Rappel : pas d'ATCD de TS ni d'hospitalisation en psychiatrie (n'en signale pas ce jour non plus).
Consommations : alcool 2 L/j, crack 1 à 2 g/j depuis le décès ("avant c'était moins"), clonazépam de rue 4 à 6 mg/j, tabac 25 cig/j. Amaigrie (49 kg).

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Hébergée à la halte de nuit jusqu'à vendredi.
Elle demande pour la première fois "d'en sortir pour de vrai", y compris du crack.
Examen : TA 128/80, pas de signe de sevrage (consommation ce matin), plaies des mains, toux. Pas d'élément psychotique.
Conclusions :
Mirtazapine 15 mg le soir (sommeil, humeur), délivrance hebdomadaire en pharmacie
Thiamine 250 mg/j
Plan : sevrage hospitalier complet (alcool, BZD, crack) dès qu'une place est disponible, couplé à une demande de CHRS ; lien avec Mme BERGEZ
Numéros d'urgence remis ; revue la semaine prochaine
EMPP poursuit le passage quotidien

Observation IDE du 02/03/2021 (Urgence : Bas)

Validé par PEYRUSSE Maryse - IDE le 02/03/2021 à 17:15
RDV non honoré avec le Dr ARRIBAT. Appel à la halte de nuit : elle y dort toujours, est partie le matin "voir le CAARUD". Ordonnance de mirtazapine laissée à la pharmacie de la gare (délivrance hebdomadaire). Nouveau RDV le 16/03 avec Mme BERGEZ et le Dr ARRIBAT le même jour.

Observation sociale du 16/03/2021 (Urgence : Bas)

Validé par BERGEZ Brigitte - Assistante sociale le 16/03/2021 à 15:30
Reprise du suivi social, après 18 mois sans contact.
Mme HOURQUEBIE est hébergée à la halte de nuit femmes, renouvelée de semaine en semaine.
- SIAO : demande de CHRS (insertion, femme seule) actualisée, avec un projet de soins (sevrage hospitalier prévu). Avis favorable de principe du CHRS Le Fanal, sous réserve du sevrage.
- RSA suspendu depuis l'été 2019 (pas de déclaration trimestrielle) : réouverture des droits demandée, rattachée à la domiciliation du CAARUD.
- Mesure de protection : Mme reconnaît ne plus pouvoir gérer, "l'argent part tout seul". Accord pour une demande de curatelle ; certificat médical circonstancié à faire par un médecin inscrit sur la liste du procureur, demandé ce jour.
- Santé : le CAARUD me signale un TROD VHC positif fait en février, elle me l'a confirmé.
- Nouveau téléphone (donné par le CAARUD) : 07 82 64 19 05.
- Papiers : carte d'identité perdue en janvier, refaite avec l'aide du CAARUD (récépissé). Carte Vitale à refaire, C2S demandée.
Mme HOURQUEBIE est plus présente qu'aux entretiens de 2018-2019, pose des questions, note les dates dans un carnet. Revoir dans 15 jours.

Observation IDE du 13/04/2021 (Urgence : Bas)

Validé par PEYRUSSE Maryse - IDE le 13/04/2021 à 14:20
Mme HOURQUEBIE vient chercher son ordonnance (mirtazapine) et ses résultats.
PCR VHC positive (charge virale 5,9 log), génotype 1a. Sérologie VIH négative. Lui ai expliqué que ça se soigne bien maintenant, en 2 ou 3 mois de comprimés, "même avec l'alcool on peut en parler". RDV hépatologie demandé, lettre faite par le Dr ARRIBAT.
Elle dort mieux avec la mirtazapine, "c'est déjà ça". Toujours beaucoup d'alcool et de crack, n'a pas voulu chiffrer.
Date du sevrage hospitalier confirmée : 07/06. Elle a dit "je serai là, promis", et elle a souri pour la première fois depuis longtemps.

Observation médicale d'entrée du 07/06/2021 (Urgence : Bas)

Dernière modification le 07/06/2021 à 19:40 par TARIS Anaïs - Interne
Observations :
Entrée programmée pour sevrage d'alcool, de benzodiazépines et de crack chez Mme HOURQUEBIE Sylvette, 49 ans, suivie au CSAPA par le Dr ARRIBAT.
Rappel des antécédents :
- TUAL sévère, usage quotidien depuis 2006, premier sevrage hospitalier en 2016 (clinique du Lac), sevrage au CH en

septembre 2018 ; crise convulsive de sevrage en novembre 2018 ; delirium tremens en janvier 2020 (réanimation).
- Crack : depuis 2020 d'après le dernier courrier ; la patiente dit aujourd'hui "en octobre 2019, quand on était sous le pont". Usage quotidien, jusqu'à 2 g/j depuis le début de l'année. Dernière prise hier soir.
- BZD : clonazépam de rue 4 à 6 mg/j depuis le printemps 2019, après l'arrêt de l'alprazolam prescrit (2015-2019).
- Tabac 25 cig/j.
- Épisode dépressif caractérisé depuis le décès de son compagnon en décembre 2020, mirtazapine 15 mg.
- Hépatopathie alcoolique (F2-F3 en 2018). VHC génotype 1a non traité.
- Expulsion de son logement en 2018, à la rue depuis.

Dernière consommation d'alcool ce matin 7h.
Examen : poids 50 kg, TA 142/88, FC 102, tremblements, Cushman 7. Lésions de brûlures cicatrisées aux doigts et aux lèvres. Mauvais état dentaire (plusieurs extractions à prévoir). Cicatrice ancienne du cuir chevelu frontal, "une chute". Hypoesthésie en chaussettes des deux pieds, ROT achilléens abolis : neuropathie à explorer. Pas de signe de confusion.
Biologie à l'entrée : GGT 520, VGM 109, plaquettes 96, TP 68 %, lipase normale.
Contexte social : hébergée à la halte de nuit depuis février, place en CHRS conditionnée à la réussite du sevrage, curatelle demandée. Motivation exprimée clairement : "je veux pas mourir sous un pont comme lui". Elle accepte que l'équipe parle au CHRS de son traitement.
Conclusions :
Protocole diazépam fixe (40 mg/j) + adaptation au Cushman, couvrant le sevrage alcool et BZD
Thiamine 500 mg IV 3 jours
Mirtazapine augmentée à 30 mg le soir
Craving crack : accompagnement IDE, pas de traitement spécifique
Fibroscan et EMG à programmer
Place CHRS Le Fanal confirmée pour le 18/06 si le séjour se passe bien

Observation infirmière du 08/06/2021 (Urgence : Bas)

Validé automatiquement le 09/06/2021 à 06:00 par LABARCHEDE Michel
Nuit difficile. Pte HOURCQUEBIE reveillee a minuit, tres irritable, veut sortir "chercher quelque chose", reconnait que c'est le crack.
Cushman 6. Diazepam 10 mg en plus selon protocole a 0h30.
Discussion sur le patio 20 min, a pleure en parlant de Jeannot.
Recouchee a 2h, dormi ensuite. Pas d'hallucinations.

Observation médicale de suivi du 18/06/2021 (Urgence : Bas)

Validé par TARIS Anaïs - Interne le 18/06/2021 à 11:15
Observations :
Sortie ce jour après 11 jours, directement vers le CHRS Le Fanal (accompagnée par l'éducatrice du CHRS, Mme LASSALLE).
Sevrage sans complication. Craving de crack intense les 4 premiers jours, puis décroissance. Pas de consommation pendant le séjour (toxiques urinaires négatifs hors BZD).
Diazépam : le relais à dose dégressive lente se fera en ambulatoire, pour le sevrage des BZD : 30 mg/j à la sortie (10-10-10).
Fibroscan 12,4 kPa (F3). EMG demandé en externe.
Conclusions :
Ordonnance de sortie : diazépam 10 mg x3 (délivrance hebdomadaire), acamprosate 333 mg 2-2-2, mirtazapine 30 mg, thiamine 250 mg/j, vitamine B6
RDV Dr ARRIBAT dans 1 mois, IDE dans 1 semaine
Hépatologie : RDV pris pour le traitement du VHC

Observation IDE du 06/07/2021 (Urgence : Bas)

Validé par PEYRUSSE Maryse - IDE le 06/07/2021 à 10:55
Premier RDV IDE depuis la sortie. Mme HOURQUEBIE est venue à pied du CHRS, "trois kilomètres, avec mes pieds qui piquent".

Diazépam 10 mg x3 pris comme prescrit, pas de demande d'avance. Acamprosate pris "presque toujours le midi aussi". Pas d'alcool, pas de crack, éthylotest négatif.
Elle dit dormir "comme jamais" avec la mirtazapine 30. Délivrance hebdomadaire organisée avec la pharmacie la plus proche du CHRS.

Observation ELSA du 24/08/2021 (Urgence : Bas)

Validé par HONTANX Cédric - IDE ELSA le 24/08/2021 à 15:40
Appel gastro-enterologie. Pte HOURQUEBIE hospitalisee depuis le 19/08 pour pancreatite aigue (lipase 14 fois la normale, TDM : pancreatite stade C, pas de calcul).
Contexte : reprise de l'OH en cachette au CHRS depuis "4 ou 5 jours", vin + biere, "une bouteille par jour, pas plus". Pas de crack depuis la sortie de juin, dit-elle.
Douleurs ameliorees, a jeun depuis 3 jours, realimentation demain.
Cushman 2, sous diazepam 30 mg (son ttt habituel). Pas de signe de sevrage.
Le CHRS garde sa place (appel de Mme LASSALLE).
Pte tres culpabilisee, "j'ai tout gache". Reassurance. Reprise acamprosate a la sortie.
Sortie prevue vendredi 27/08.

Transmission CAARUD du 21/09/2021 (Urgence : Bas)

Validé par GUIRAUD Mathieu - Éducateur spécialisé le 21/09/2021 à 12:10
Entretien avec Mme HOURQUEBIE, puis transmission, avec son accord écrit, d'une information qu'elle avait confiée à Mme DUTHIL (CAARUD La Passerelle) et qu'elle souhaitait que "les soignants sachent, mais sans en parler à chaque fois" :
pendant la période de rue, à partir du printemps 2020 et jusqu'au décès de son compagnon en janvier 2021, Mme s'est prostituée "pour payer la galette", sur les boulevards, environ deux à trois fois par semaine. Elle ne le faisait pas au moment de l'hôtel du confinement, puis "c'est revenu cet été-là". Jeannot "savait mais disait rien". Rapports protégés "la plupart du temps" (préservatifs pris au CAARUD). Elle dit avoir été frappée par un client une fois, sans porter plainte.
Mme DUTHIL lui avait proposé un dépistage complet à ce moment-là, fait au CAARUD (TROD VIH négatif, TROD VHC positif en février 2021).
Elle précise qu'elle n'avait "jamais fait ça avant la rue" et qu'elle a arrêté "le jour où Jeannot est mort". Elle ne veut pas que cela soit écrit dans les courriers adressés au CHRS ni au médecin traitant : respecté.
Mme HOURQUEBIE dit qu'elle en parlera "peut-être" à la psychologue.
Je rappelle à Mme HOURQUEBIE que cette information reste dans le dossier de soins et n'est pas transmise à la curatelle ni au CHRS. Elle remercie, "Kenza m'a jamais jugée".
Transmission CHRS (Mme LASSALLE) : bonne intégration au Fanal, participe à l'atelier cuisine, respecte le règlement. Une alcoolisation connue en août (pancréatite). Pas d'autre consommation repérée.

Observation psychologue du 12/10/2021 (Urgence : Bas)

Validé par CASTAGNET Bérengère - Psychologue le 12/10/2021 à 17:20
Premier entretien, à la demande du Dr ARRIBAT.
Mme HOURQUEBIE se présente soignée, la voix basse. Elle parle surtout de Jeannot, de "la tente", du matin où elle l'a trouvé. Les cauchemars sont presque quotidiens depuis, avec des réveils en sursaut ; elle vérifie plusieurs fois par nuit que sa voisine de chambre respire.
Elle évoque très vite, puis referme, "des choses d'avant, avec le père de mes enfants", "on verra".
Elle se décrit comme "quelqu'un qui a tout raté", alors qu'elle s'exprime avec précision et une certaine culture (cite des livres lus à la bibliothèque du CHRS).
Elle décrit la vie dans la tente avec une précision qui frappe : l'ordre des gestes le matin, la manière de cacher l'argent, les nuits où "on dormait à tour de rôle". Elle dit n'avoir "jamais eu aussi peur et jamais été aussi libre". Elle ne parle pas du crack ni de l'argent de cette période, et je ne pose pas de question.
Sur son histoire plus ancienne, elle dit seulement avoir "travaillé longtemps" et avoir "perdu les enfants", sans détailler.
Proposition d'un rythme d'un entretien tous les 15 jours, acceptée. Un travail de deuil est le premier objectif qu'elle se donne ; le second, dit-elle, "arrêter d'avoir honte quand je croise quelqu'un de Marmande".

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Observation psychiatrique de suivi du 09/11/2021 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBAT Ségolène - Psychiatre addictologue le 09/11/2021 à 18:15

Observations :
Vue ce jour.
Au CHRS Le Fanal depuis le 18/06. Abstinente d'alcool depuis la sortie de gastro fin août, pas de crack depuis le 07/06 (dépistages urinaires du CHRS négatifs).
Diazépam 30 mg/j bien pris, pas de chevauchement, demande elle-même à diminuer.
Humeur un peu meilleure, cauchemars fréquents (cf. psychologue). Idées de mort moins présentes, pas d'idées suicidaires.
VHC : traitement par sofosbuvir/velpatasvir débuté le 18/10 pour 12 semaines (hépatologue du CH), bonne observance, pilulier.
EMG du 03/11 : en attente du compte rendu.
Conclusions :
Diazépam 20 mg/j (5-5-10)
Acamprosate, mirtazapine 30 mg, thiamine inchangés
RDV 2 mois ; IDE tous les 15 jours pour la délivrance

Transmission CHRS du 11/01/2022 (Urgence : Bas)

Validé par GUIRAUD Mathieu - Éducateur spécialisé le 11/01/2022 à 14:00

Appel de Mme LASSALLE (CHRS Le Fanal) : Mme HOURQUEBIE a passé les fêtes au CHRS, sans consommation repérée. Traitement du VHC terminé début janvier (12 semaines), "pas oublié un seul comprimé", pilulier tenu par elle. Elle a demandé à aider à la comptabilité de l'atelier cuisine. Audience de curatelle passée, jugement attendu.

Observation sociale du 25/01/2022 (Urgence : Bas)

Validé par BERGEZ Brigitte - Assistante sociale le 25/01/2022 à 16:55

Entretien au CSAPA, puis appel à la future curatrice.
1) Mesure de protection : jugement du juge des contentieux de la protection du 18/01/2022, curatelle renforcée pour 5 ans, confiée à l'Association tutélaire fictive de Gironde (mandataire : Mme Solange BARRÈRE). Mme HOURQUEBIE "soulagée et vexée en même temps". Premier RDV avec la curatrice le 03/02.
2) Retraite et droits : pour la demande d'AAH et pour reconstituer ses droits, j'avais demandé son relevé de carrière (avec son accord) ; reçu ce mois-ci. Il ne correspond pas du tout à ce qui était noté jusqu'ici ("intérim, petits boulots") : Mme HOURQUEBIE a été salariée de façon continue de 1991 à 2014, 23 ans, dans la même entreprise de transport routier (Transports fictifs Lamarque, d'abord à Marmande puis à l'agence de Bordeaux), comme secrétaire puis secrétaire comptable. Fin du contrat en 2014 par un licenciement (elle précise : "pour absences, j'étais plus capable de venir le lundi").
Quand je le lui montre, elle se met à pleurer : "j'avais honte de dire que j'avais eu une vraie vie, une maison, un travail, et que j'ai tout perdu". Elle tenait la comptabilité de l'agence, "les gros clients, c'était moi".
Cela ouvre des droits à la retraite non négligeables plus tard, et la possibilité d'un projet d'activité, à travailler avec M. GUIRAUD.
3) AAH : dossier MDPH à constituer (certificat médical à demander au Dr ARRIBAT : séquelles somatiques, neuropathie, troubles thymiques).
4) RSA rétabli depuis l'été, versé sur un compte ouvert au CHRS.
5) Elle demande s'il serait possible, plus tard, de "refaire de la compta, même bénévole". Je note l'envie, c'est la première fois qu'elle formule un projet qui ne concerne pas seulement l'hébergement ou les soins.

Observation ELSA du 22/02/2022 (Urgence : Bas)

Validé par HONTANX Cédric - IDE ELSA le 22/02/2022 à 11:30

Appel ortho. Pte HOURQUEBIE hospitalisee depuis le 19/02 au soir : chute dans l'escalier du CHRS, alcoolisee (1,9 g/L aux urgences). Fracture bimalleolaire cheville G, operee le 20/02 (osteosynthese).
Reconnait avoir rebu "depuis 10 jours", vin le soir dehors, "apres un coup de fil de ma soeur pour l'anniversaire de ma mere". Pas de crack.
TDM cerebrale faite aux urgences (chute + alcool) : pas de lesion aigue, mais "sequelle de contusion frontale droite

ancienne". Interrogee : "c'est le pere de mes enfants, en 2005, il m'a poussee dans l'escalier, j'ai perdu connaissance, 2 jours a l'hopital de Marmande". Dit n'en avoir jamais parle "a personne ici". A dit "accident domestique" a l'epoque.
Sous diazepam 15 mg/j (dose CSAPA, recue de la pharmacie). Cushman 3. Pas de signe de sevrage.
Info Dr ARRIBAT + psychologue (avec son accord).
Sortie prevue 26/02 au CHRS, botte 6 semaines, sans appui. Le CHRS accepte (chambre au rez-de-chaussee).

Observation psychologue du 15/03/2022 (Urgence : Bas)

Validé par CASTAGNET Bérengère - Psychologue le 15/03/2022 à 17:45
Entretien long, Mme HOURQUEBIE arrive en béquilles.
Elle revient d'elle-même sur ce qu'elle a dit à l'infirmier après sa chute : "puisque c'est sorti, autant tout dire".
Elle raconte les violences de son ex-mari, Bruno TOULOUZE, de 1996 environ (après la naissance de Mélanie) jusqu'à la séparation en 2006 : insultes, contrôle de l'argent et de ses sorties, coups "quand il avait bu", à plusieurs reprises devant les enfants. En 2005, il l'a poussée dans l'escalier de la maison, perte de connaissance, deux jours à l'hôpital, "j'ai dit que j'étais tombée". Elle est partie en 2006, avec les enfants, chez sa mère ; divorce en 2008. Jamais de plainte.
"Ça s'est mal fini, il buvait aussi" : c'est ce qu'elle disait jusqu'ici, elle sourit tristement en le rappelant.
Elle commence à boire le matin à ce moment-là, "pour tenir le coup", au travail aussi.
Symptomatologie : cauchemars de la scène de l'escalier, reviviscences quand on monte la voix, évitement des hommes alcoolisés, hypervigilance, sursauts ; aggravés depuis le décès de Jeannot. PCL-5 à 52. Tableau compatible avec un trouble de stress post-traumatique (complexe), à confirmer avec le Dr ARRIBAT.
Elle relie elle-même le début de l'alcool du matin à cette période, et l'escalade de 2008 aux démarches du divorce, "quand il fallait le revoir chez l'avocat".
Elle dit aussi que Jeannot "n'a jamais levé la main sur moi", et que c'est pour ça qu'elle "le suivait partout", même sous le pont.
Je lui propose, quand la stabilité le permettra, un travail spécifique (EMDR). Elle demande "à ne pas raconter tout ça à chaque nouveau médecin".

Observation psychiatrique de suivi du 05/04/2022 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBAT Ségolène - Psychiatre addictologue le 05/04/2022 à 18:40
Observations :
Vue ce jour, en béquilles (fracture bimalléolaire de la cheville G opérée le 20/02 après une chute alcoolisée au CHRS).
Révélations récentes (cf. notes ELSA et psychologue, en accord avec elle) : violences conjugales de 1996 à 2006, traumatisme crânien en 2005 avec perte de connaissance (séquelle frontale droite au scanner du 19/02). Je retiens un trouble de stress post-traumatique, ancien, réactivé par le deuil. Travail en psychothérapie, EMDR envisagé.
Alcool : rechute de 10 jours en février, abstinente depuis l'hospitalisation. Pas de crack.
EMG du 03/11/2021 (compte rendu reçu) : polyneuropathie sensitive axonale des membres inférieurs, d'origine alcoolique et carentielle probable. Paresthésies douloureuses la nuit.
Diazépam 15 mg/j depuis le 22/02 (diminué pendant le séjour en orthopédie, à sa demande).
Humeur : épisode dépressif en rémission partielle, sommeil meilleur, cauchemars fréquents.
Conclusions :
Diazépam 15 mg/j (5-5-5)
Mirtazapine 30 mg, acamprosate 2-2-2, thiamine, vitamine B6 ; kinésithérapie
Pas de gabapentinoïde (risque de mésusage), en discuter avec elle si les douleurs persistent
Certificat MDPH rempli
Repris avec elle : le diagnostic de TSPT n'enlève rien au trouble de l'usage, mais "explique pourquoi l'alcool est arrivé le matin en 2006" ; elle dit se sentir "moins folle".
RDV 2 mois

Entretien téléphonique du 07/06/2022 (Urgence : Bas)

Validé par PEYRUSSE Maryse - IDE le 07/06/2022 à 09:50
Appel de la pharmacie du quartier Saint-Jean : Mme HOURQUEBIE demande ses 7 jours de diazépam avec 2 jours d'avance.
Rappel de Mme HOURQUEBIE : elle a "fait tomber la boîte dans l'évier", 4 comprimés perdus. Pas d'autre

chevauchement depuis le début, la curatrice confirme qu'elle n'a pas d'argent en plus cette semaine. Accord donné à la pharmacie pour cette fois, délivrance normale ensuite. Info au Dr ARRIBAT.

Transmission CHRS du 20/09/2022 (Urgence : Bas)

Validé par GUIRAUD Mathieu - Éducateur spécialisé le 20/09/2022 à 16:30
Entretien éducatif, en lien avec Mme LASSALLE (éducatrice référente au CHRS Le Fanal).
Mme HOURQUEBIE souhaite reprendre contact avec sa fille Mélanie, 27 ans, dont elle a retrouvé l'adresse par une cousine. Elle veut lui écrire et me demande de l'aider à "trouver les mots".
En préparant la lettre, elle explique pour la première fois que ses enfants ne sont pas "partis vivre chez leur père" en 2009 comme elle l'avait dit : ils ont été placés par le juge des enfants (ASE du Lot-et-Garonne), en famille d'accueil à Tonneins, de 2009 à 2012, "après mon hospitalisation, quand j'étais tombée trop bas". Ils sont ensuite allés chez leur père, Teddy jusqu'à sa majorité. Elle dit que c'est "la vraie honte", plus que l'alcool : "on me les a pris".
Elle ne veut pas en dire plus aujourd'hui sur cette hospitalisation. Je n'insiste pas.
Elle raconte les visites médiatisées à Tonneins, "une heure tous les quinze jours, avec une éducatrice dans la pièce", et la dernière fois qu'elle a vu Teddy enfant, à 14 ans. Elle n'a jamais eu de nouvelles des décisions du juge après 2012, "je ne voulais plus ouvrir les courriers".
La lettre est écrite, elle l'enverra elle-même. Transmis au Dr ARRIBAT et à Mme CASTAGNET avec son accord.
CHRS : pas de consommation repérée depuis février. Participe à l'atelier comptabilité de l'association, "elle remet les factures en ordre mieux que nous" (Mme LASSALLE).

Observation psychiatrique de suivi du 18/10/2022 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBAT Ségolène - Psychiatre addictologue le 18/10/2022 à 17:50
Observations :
Vue ce jour.
Abstinente d'alcool depuis fin février. Pas de crack.
Acamprosate arrêté de sa propre initiative début octobre ("trop de comprimés, j'en ai plus besoin"). Accepté, à revoir en cas de craving.
Diazépam 15 mg bien toléré, demande la suite de la dégression.
VHC : réponse virologique soutenue (PCR négative à 12 semaines, en septembre). Guérie.
Évoque le placement de ses enfants (cf. éducateur), émue mais "c'est mieux que ça soit dit". A écrit à sa fille, pas encore de réponse.
Marche sans canne. Paresthésies stables.
Conclusions :
Diazépam 10 mg/j (5-0-5)
Mirtazapine 30 mg, thiamine
RDV 2 mois

Observation psychologue du 10/01/2023 (Urgence : Bas)

Validé par CASTAGNET Bérengère - Psychologue le 10/01/2023 à 17:30
Mme HOURQUEBIE arrive en avance, souriante, avec une photo sur son téléphone.
Mélanie a répondu à sa lettre début décembre. Elles se sont retrouvées le 24/12 dans un café à Bordeaux, "deux heures, on a pleuré toutes les deux". Mélanie est enceinte (terme en octobre), "elle veut que je sois là si je vais bien".
Teddy n'a pas répondu, Mélanie dit qu'il "n'est pas prêt".
Elle reconnaît aussi un "verre de champagne" le 24 au soir, "un seul". Craving les jours suivants, gérés.
Nous fixons le début du travail EMDR au printemps, une fois la situation stabilisée.

Observation IDE du 07/02/2023 (Urgence : Bas)

Validé par PEYRUSSE Maryse - IDE le 07/02/2023 à 11:10
Renouvellement du diazépam 10 mg (délivrance hebdomadaire) et de la mirtazapine. Mme HOURQUEBIE est venue avec Mme BARRÈRE, sa curatrice, pour signer des papiers au secrétariat.
Elle paraît fatiguée, dit "le boulot de la cuisine du CHRS". Haleine ? je n'ai pas senti d'alcool mais elle évitait de s'approcher. Pas de test fait. Je le note pour le Dr ARRIBAT.

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Observation psychiatrique de suivi du 14/03/2023 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBAT Ségolène - Psychiatre addictologue le 14/03/2023 à 18:35

Observations :
Vue ce jour, à la suite d'un appel de Mme LASSALLE (CHRS) qui signale des alcoolisations depuis janvier : bouteilles retrouvées dans la chambre, retours tardifs.
Mme HOURQUEBIE le reconnaît après un temps : reprise "après les fêtes", début janvier, "le soir, en cachette", 1 bouteille de vin par jour, parfois plus le week-end. Pas de consommation matinale, pas de crack ("ça, non, jamais plus").
Elle évoque l'attente de la réponse de son fils, l'approche de l'anniversaire du décès de Jeannot.
GGT 186, CDT 3,2 %.
Elle demande "une vraie coupure" avant de quitter le CHRS : demande de SSR addictologique (postcure), déjà évoquée.
Le CHRS accepte de garder sa chambre pendant le séjour, à condition qu'il ne dépasse pas deux mois.
Diazépam : diminué à 7,5 mg/j comme prévu, mais je ne veux pas descendre plus vite dans ce contexte.
Conclusions :
Demande d'admission en SSR addictologique à la clinique fictive des Pins-Gris (courrier fait ce jour)
Diazépam 7,5 mg/j (2,5-0-5)
Mirtazapine 30 mg, thiamine
IDE hebdomadaire jusqu'à l'entrée

Observation psychiatrique de suivi du 13/06/2023 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBAT Ségolène - Psychiatre addictologue le 13/06/2023 à 18:10

Observations :
Vue ce jour, sortie du SSR addictologique des Pins-Gris le 09/06/2023 après un séjour du 17/04 au 09/06, abstinente depuis l'entrée, dit avoir "retrouvé de l'énergie".
Compte rendu du SSR reçu ce jour. Le médecin du SSR a obtenu, avec l'accord de la patiente, le dossier du CH fictif du Val-de-Garonne (Marmande), où elle avait été suivie. Ce dossier ancien apporte deux éléments qui ne figuraient pas dans notre dossier et qui corrigent l'observation d'entrée :
- une intoxication médicamenteuse volontaire en 2007 (paracétamol et anxiolytiques, après la séparation), avec 2 jours de réanimation à Marmande, puis un suivi en CMP quelques mois ;
- un premier sevrage hospitalier d'alcool en 2009, à Marmande (environ 3 semaines), après une alcoolisation massive ; c'est cette hospitalisation qui avait précédé le placement des enfants. Le sevrage de 2016 à la clinique du Lac n'était donc pas le premier.
Reprise avec elle : confirme les deux, "je ne voulais pas qu'on me prenne pour une folle en plus". À l'entrée en 2018 et en 2021 elle avait répondu "jamais" pour un geste suicidaire. Aucune idée suicidaire depuis 2021.
Le SSR décrit un séjour investi (groupes de prévention de la rechute, atelier mémoire), un MoCA à 25/30 (fonctions exécutives) à recontrôler. Pas de consommation pendant le séjour, une seule permission de week-end, chez sa fille, sans incident. L'équipe du SSR note aussi une "grande difficulté à demander de l'aide, compensée par une très bonne capacité d'organisation".
Elle me dit qu'à Marmande, en 2009, elle avait "juré de ne plus jamais boire" et avait tenu "deux mois". Elle se souvient de l'infirmière qui l'avait aidée à téléphoner aux enfants depuis le service. Émotion importante, mais pas de déstabilisation.
Diazépam 5 mg/j pendant le séjour.
Conclusions :
Diazépam 5 mg/j, mirtazapine 30 mg
Pas d'aide à l'abstinence médicamenteuse souhaitée
Psychothérapie et début de l'EMDR avec Mme CASTAGNET
Projet de pension de famille (Mme BERGEZ)
RDV 2 mois

Observation sociale du 19/09/2023 (Urgence : Bas)

Validé par BERGEZ Brigitte - Assistante sociale le 19/09/2023 à 15:20

Entrée à la pension de famille Les Ajoncs le 01/09/2023 : studio, 5 impasse des Fictifs, 33150 CENON. Sortie du CHRS Le Fanal fin août, bilan très positif de l'équipe.
Logement durable (pas de durée limitée), hôte de maison sur place, repas collectifs 2 fois par semaine.

Curatelle : loyer et charges réglés par Mme BARRÈRE, argent de vie hebdomadaire. Dossier de surendettement : effacement de la dette locative de Bègles (rétablissement personnel) en juillet.
MDPH : dossier AAH déposé en juin, en attente.
Mme HOURQUEBIE "n'arrive pas à y croire", a acheté une plante pour le studio.
Santé : RDV dentaire obtenu (soins complets, prise en charge C2S), pédicure-podologue pour la neuropathie.
Le CHRS transmet une fiche de liaison (Mme LASSALLE) : 26 mois de séjour, une alcoolisation en août 2021, une en février 2022, des alcoolisations cachées début 2023, aucun incident avec les autres résidents. "Une des personnes qui nous a le plus appris sur l'entraide."

Synthèse annuelle du 07/11/2023 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBAT Ségolène - Psychiatre addictologue le 07/11/2023 à 19:30
Observations :
Synthèse annuelle du suivi au CSAPA (suivie depuis mai 2018).

Mme HOURQUEBIE Sylvette, 51 ans, née à Marmande. Secrétaire comptable pendant 23 ans dans une entreprise de transport (1991-2014), licenciée en 2014. Mariée en 1994 à M. TOULOUZE, deux enfants (Mélanie, née en 1995, et Teddy, né en 1998). Violences conjugales de 1996 à 2006, avec un traumatisme crânien en 2005 ; séparation en 2006, divorce en 2008. Placement des enfants par l'ASE de 2009 à 2012.

Alcool : premier verre vers 14 ans, usage quotidien depuis la séparation de 2006, perte de contrôle vers 2008. Sevrages hospitaliers : 2009 (Marmande), 2016 (clinique du Lac), septembre 2018 et juin 2021 (CH) ; crise convulsive de sevrage le 18/11/2018 ; delirium tremens en janvier 2020 (réanimation). Rechutes brèves en août 2021 (pancréatite aiguë), en février 2022 (chute, fracture de la cheville gauche), puis de janvier à avril 2023. SSR addictologique aux Pins-Gris d'avril à juin 2023. Abstinente depuis le 17/04/2023.

Benzodiazépines : alprazolam prescrit de 2015 à 2019, clonazépam de rue de 2019 à 2021, relais par diazépam en juin 2021 (30 mg) et dégression lente : 5 mg/j actuellement.

Crack : débuté en octobre 2019 pendant la période de rue, quotidien en 2020-2021 (jusqu'à 2 g/j), arrêté depuis le sevrage de juin 2021.

Tabac : 25 cig/j, pas de demande d'arrêt.

Psychiatrie : épisodes dépressifs en 2016 et en 2018 (sertraline 2018-2019), IMV en 2007 (réanimation, Marmande), épisode dépressif sévère après le décès de son compagnon le 19/01/2021 (mirtazapine depuis le 02/02/2021, rémission partielle depuis 2022). Trouble de stress post-traumatique en lien avec les violences conjugales, réactivé par le deuil, diagnostiqué en 2022 ; psychothérapie depuis octobre 2021, EMDR depuis juillet 2023.

Somatique : hépatopathie alcoolique F3 (fibroscan 12,4 kPa en 2021), VHC traité en 2021-2022 et guéri, pancréatite aiguë en août 2021, polyneuropathie sensitive des membres inférieurs, fracture bimalléolaire de la cheville gauche opérée en février 2022, séquelle frontale de TC ancien. MoCA 25/30 au SSR.

Social : expulsion le 16/04/2019, rue de 2019 à 2021 (tente, squats, hôtel 115 au confinement), garde à vue en août 2020, CHRS Le Fanal de juin 2021 à août 2023, pension de famille Les Ajoncs à Cenon depuis le 01/09/2023. Curatelle renforcée depuis janvier 2022. RSA, AAH demandée. Reprise de contact avec sa fille fin 2022 ; naissance de son petit-fils Lyam le 14/10/2023, qu'elle a pu voir à la maternité.

Traitements successifs : sertraline (2018-2019), baclofène (2018-2019, perdu à l'expulsion), mirtazapine (depuis 2021), acamprosate (juin 2021 - octobre 2022, arrêté par elle), diazépam en dégression depuis juin 2021, traitement antiviral du VHC (octobre 2021 - janvier 2022).
Partenaires : EMPP (2019-2021), CAARUD La Passerelle (depuis 2019), CHRS Le Fanal, SSR des Pins-Gris, curatrice (Association tutélaire fictive de Gironde), médecin traitant le Dr LAVERNY, hépatologie du CH.

Aujourd'hui : abstinente, pas de crack, humeur stable, cauchemars plus rares depuis l'EMDR. Fatigue, paresthésies des pieds. Investit la pension de famille (atelier jardin).

Conclusions :
Diazépam 5 mg/j, arrêt prévu en janvier-février
Mirtazapine 30 mg
Fibroscan de contrôle en 2024, MoCA à refaire
Proposition d'aide au sevrage tabagique : pas pour l'instant
RDV 2 mois

Observation IDE du 20/02/2024 (Urgence : Bas)

Validé par PEYRUSSE Maryse - IDE le 20/02/2024 à 10:40
Mme HOURQUEBIE vient me dire, toute fière, qu'elle a pris son dernier demi-comprimé de diazépam le 10/02. "Près de trois ans pour descendre, mais c'est fait." Un peu d'insomnie la première semaine, pas d'anxiété majeure, pas de tremblements. Elle n'en veut plus du tout et me rend la boîte entamée.
Mirtazapine 30 mg poursuivie. Pas d'alcool, pas de crack.
Elle me montre des photos de Lyam, "il a quatre mois".
Prochain RDV avec le Dr ARRIBAT en juin.

Observation éducative du 21/05/2024 (Urgence : Bas)

Validé par GUIRAUD Mathieu - Éducateur spécialisé le 21/05/2024 à 14:15
Entretien à sa demande, plus tôt que prévu.
Mme HOURQUEBIE a refumé du crack pendant environ trois semaines, en avril : elle a recroisé à la gare "une copine de la rue" en allant voir sa fille, "elle m'a proposé, j'ai pas su dire non". Plusieurs fois par semaine, "jamais plus d'un demi-gramme", payé avec l'argent de vie de la curatelle, d'où un découvert que Mme BARRÈRE a signalé. Arrêt depuis le 05/05, "quand j'ai vu dans quel état était la copine".
Pas d'alcool associé selon elle, mais "deux ou trois verres de vin" à des repas, à la pension de famille, depuis le début de l'année, "pas tous les jours, et j'en ai pas envie le lendemain".
Elle est revenue au CAARUD une fois pour prendre des pipes propres, Mme DUTHIL a fait le lien avec moi.
Honte importante, peur de "tout reperdre". Travail sur les situations à risque (gare, trajet vers sa fille) : elle prendra désormais le tram par un autre chemin.
Transmis au Dr ARRIBAT, RDV avancé.

Observation psychiatrique de suivi du 04/06/2024 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBAT Ségolène - Psychiatre addictologue le 04/06/2024 à 18:25
Observations :
Vue ce jour.
Rechute de crack en avril 2024, environ 3 semaines, arrêtée le 05/05 (cf. M. GUIRAUD). Pas de consommation depuis.
Craving faible.
Alcool : 2 à 3 verres de vin, 2 ou 3 fois par semaine depuis janvier, sans perte de contrôle actuelle dit-elle, mais elle "aimerait ne pas retomber" et ne se sent pas capable d'une abstinence totale à table.
Proposition de nalméfène à la demande (objectif de réduction), acceptée.
Fibroscan du 15/05 : 8,1 kPa (amélioration nette). GGT 64.
Humeur stable. Sommeil correct sans diazépam.
Conclusions :
Nalméfène 18 mg à prendre 1 à 2 heures avant une situation de consommation possible
Mirtazapine 30 mg
RDV 2 mois

Observation IDE du 15/10/2024 (Urgence : Bas)

Validé par PEYRUSSE Maryse - IDE le 15/10/2024 à 16:30
RDV non honoré. Appel : elle était à l'anniversaire de Lyam (un an) chez sa fille, "j'ai complètement zappé, pardon".

Nouveau RDV le 22/10.
Nous fait savoir que sa nouvelle adresse mail est sylvette.hourquebie72@fictif.fr (la pension de famille l'a aidée à la créer), pour recevoir les rappels.

Observation psychologue du 03/12/2024 (Urgence : Bas)

Validé par CASTAGNET Bérengère - Psychologue le 03/12/2024 à 17:40
Séance d'EMDR (cible : la scène de l'escalier en 2005). SUD de 7 à 2 en fin de séance. Les cauchemars de cette scène ont "presque disparu" depuis l'été.
Elle a écrit à son fils Teddy en octobre, avec l'aide de Mélanie. Réponse reçue la semaine dernière par message : il ne souhaite pas la voir "pour l'instant", "tu nous as laissés". Elle est très affectée, a pleuré toute la séance, mais dit vouloir "respecter son choix".
Elle me dit boire "un peu plus le soir" depuis ce message, sans pouvoir le chiffrer. L'anniversaire du décès de Jeannot approche.
Séances hebdomadaires en décembre-janvier. Dr ARRIBAT prévenu avec son accord.

Observation IDE du 04/02/2025 (Urgence : Bas)

Validé par PEYRUSSE Maryse - IDE le 04/02/2025 à 15:15
Mme HOURQUEBIE vient sans RDV, tremblante, haleine alcoolisée.
Elle a "replongé" depuis mi-janvier, après l'anniversaire de la mort de Jeannot (19/01) : boit maintenant environ 1 litre de vin par jour, dès 10h, "pour arrêter de trembler", et le nalméfène "je ne le prends plus, ça sert à rien quand on a déjà commencé". Pas de crack. Le refus de Teddy en décembre "est resté là" (montre sa gorge).
Cushman à 5. Elle demande un sevrage mais "pas l'hôpital, je veux pas perdre ma place aux Ajoncs".
Avis du Dr ARRIBAT par téléphone : sevrage ambulatoire possible (hôte de la pension présent, pas de convulsion depuis 2018 mais ATCD de DT : passage IDE quotidien obligatoire). RDV médical le 11/02, d'ici là ne pas arrêter brutalement, réduire progressivement.
Appel à l'hôte de maison de la pension, avec son accord.

Observation psychiatrique de suivi du 11/02/2025 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBAT Ségolène - Psychiatre addictologue le 11/02/2025 à 18:05
Observations :
Vue ce jour, accompagnée de l'hôte de la pension de famille.
Rechute depuis mi-janvier 2025, environ 1 L/j, consommation matinale. Nalméfène arrêté par elle fin janvier (pris irrégulièrement depuis l'automne). Pas de crack, pas de BZD de rue.
Rappel : ATCD de crise convulsive de sevrage (11/2018) et de DT (01/2020) : sevrage ambulatoire sous surveillance rapprochée, accepté avec un cadre écrit (IDE CSAPA ou pension tous les jours, retour aux urgences au moindre signe de confusion).
Humeur : triste, pas d'idées suicidaires, "je veux être là pour Lyam".
Conclusions :
Sevrage ambulatoire à partir de ce soir : diazépam 10 mg x4 J1-J2, puis 10 mg x3, décroissance sur 7 jours, délivrance quotidienne
Thiamine 500 mg/j
Nalméfène arrêté
Acamprosate à débuter en fin de sevrage
RDV IDE quotidien, médical dans 3 semaines

Observation IDE du 18/02/2025 (Urgence : Bas)

Validé par PEYRUSSE Maryse - IDE le 18/02/2025 à 11:50
Fin du sevrage ambulatoire, J7 : dernière prise de diazépam (5 mg) ce matin. Aucun signe de sevrage depuis J3, Cushman à 1. Pas d'alcool depuis le 11/02 au soir, éthylotest négatif tous les jours.
Elle a tenu un carnet, "pour Mme CASTAGNET".
Début de l'acamprosate 333 mg 2-2-2 ce jour, comme prévu par le Dr ARRIBAT. Ordonnance pour 1 mois. Mirtazapine 30 mg poursuivie.

Elle a dormi chez sa fille le week-end, "Mélanie m'a surveillée comme le lait sur le feu".

Observation psychiatrique de suivi du 13/05/2025 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBAT Ségolène - Psychiatre addictologue le 13/05/2025 à 18:20
Observations :
Vue ce jour.
Abstinente depuis le 11/02/2025 (fin du sevrage ambulatoire le 18/02). Acamprosate 2-2-2 bien pris, "ça m'aide le soir".
Pas de crack, pas de BZD.
Elle demande pour la première fois de l'aide pour le tabac : 25 cigarettes par jour depuis l'âge de 15 ans, essoufflement à la montée de la côte de Cenon, et "Lyam qui dit que je sens la cigarette". Fagerström 7. CO expiré 24 ppm.
Neuropathie : paresthésies stables, marche correcte, plus de chute depuis 2022.
Humeur : bonne, investit l'atelier jardin, garde Lyam un mercredi sur deux chez sa fille.
Sa mère, 85 ans, est hospitalisée à Marmande depuis avril (insuffisance cardiaque) ; elle y a revu sa sœur Ginette.
Conclusions :
Substituts nicotiniques : patch 21 mg/24h + formes orales, objectif de réduction puis arrêt
Acamprosate 333 mg 2-2-2, mirtazapine 30 mg
Suivi tabacologique IDE mensuel
RDV 3 mois

Entretien téléphonique du 15/07/2025 (Urgence : Bas)

Validé par PEYRUSSE Maryse - IDE le 15/07/2025 à 09:30
Appel de Mme HOURQUEBIE : sa mère, Mme Paulette HOURQUEBIE, est décédée le 08/07/2025 à l'hôpital de Marmande. Obsèques le 12/07 à Marmande.
Elle y est allée avec Mélanie. Son fils Teddy était là : "il est venu vers moi au cimetière, il m'a prise dans ses bras". Ils ont pris un café après, ont échangé leurs numéros, "on va se revoir en août".
Pas d'alcool, "même au repas après, j'ai pris du Coca, Ginette n'en revenait pas". Craving fort le soir des obsèques, elle a appelé l'hôte de la pension et pris ses gommes.
Tabac : 10 cigarettes par jour avec le patch.
Pleure de tristesse "mais pas comme pour Jeannot, là c'est normal".
Lui propose de venir en parler avec Mme CASTAGNET, séance avancée au 22/07. RDV Dr ARRIBAT maintenu en août.

Observation psychiatrique de suivi du 26/08/2025 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBAT Ségolène - Psychiatre addictologue le 26/08/2025 à 17:55
Observations :
Vue ce jour.
Décès de sa mère le 08/07 ; deuil vécu avec tristesse, sans éléments dépressifs caractérisés : sommeil correct, appétit conservé, pas d'idées de mort. Elle a revu Teddy deux fois en août ; il vit à Agen. "Il m'appelle maman."
Abstinente depuis février. Acamprosate poursuivi. Tabac : 10 cigarettes par jour avec patch 21 mg, ne souhaite pas descendre plus pour l'instant.
Courrier de la MDPH reçu en juin : AAH accordée (taux 50-79 %, restriction substantielle d'accès à l'emploi), à compter de juin 2025 (cf. Mme BERGEZ).
Conclusions :
Poursuite acamprosate 333 mg 2-2-2, mirtazapine 30 mg, substituts nicotiniques
RDV 2 mois

Observation sociale du 23/09/2025 (Urgence : Bas)

Validé par BERGEZ Brigitte - Assistante sociale le 23/09/2025 à 14:40
Point avec Mme HOURQUEBIE et sa curatrice, Mme BARRÈRE, à la pension de famille.
- AAH accordée par la MDPH à compter de juin 2025, en remplacement du RSA. Rappel versé en août.
- Curatelle renforcée : arrive à échéance en janvier 2027. Mme HOURQUEBIE souhaite un allègement en curatelle simple. Mme BARRÈRE est favorable à terme : "elle tient ses comptes mieux que la moitié de mes majeurs". Requête à préparer pour l'échéance, avec un certificat médical.

- Succession de sa mère : maison à Marmande en indivision avec sa sœur, pas de décision.
- Projet : elle voudrait une activité, "pas tout de suite un vrai travail". Lien fait avec M. GUIRAUD (bénévolat, chantier d'insertion administratif).
Rien de nouveau sur le logement : elle se sent bien aux Ajoncs, pas de demande de logement autonome pour l'instant.

Bilan psychologique du 18/11/2025 (Urgence : Bas)

Validé par CASTAGNET Bérengère - Psychologue le 18/11/2025 à 18:10
Bilan de fin de psychothérapie, à quatre ans du premier entretien (12/10/2021), d'un commun accord.

Cadre : entretiens tous les 15 jours d'octobre 2021 à 2023, puis travail EMDR de juillet 2023 à septembre 2025 (environ 30 séances), puis espacement mensuel. Interruption pendant le SSR (avril-juin 2023).

Ce qui a été travaillé :
- le deuil de Jean-Luc MAUBOURGUET, décédé le 19/01/2021, et la culpabilité attachée au "matin de la tente" ;
- les violences conjugales de 1996 à 2006, la scène de l'escalier en 2005 (traumatisme crânien), le départ de 2006 ;
- la honte autour de l'hospitalisation de 2009, de l'intoxication médicamenteuse de 2007 et du placement des enfants (2009-2012), longtemps tus ;
- la période de rue (2019-2021), dont ce qu'elle a confié au CAARUD ; elle a pu en parler ici à partir de 2023, "sans que ça me salisse" ;
- le métier perdu : elle peut aujourd'hui dire qu'elle a été "une bonne comptable pendant vingt ans" sans que cela lui paraisse un mensonge.

Évolution : PCL-5 à 52 en mars 2022, à 21 en octobre 2025. Cauchemars rares (moins d'une fois par mois). Plus d'évitement massif. Les reviviscences persistent aux cris d'hommes ivres dans la rue, mais elle peut s'en éloigner. Thymie stable, pas d'idée suicidaire depuis 2021. Les rechutes (avril 2024 pour le crack, janvier 2025 pour l'alcool) ont été repérées tôt et suivies d'une demande d'aide, ce qui n'avait jamais été le cas avant.
Relations : sa fille et son petit-fils réguliers ; son fils revu depuis juillet 2025 ; reprise de contact avec sa sœur.

Ce qui l'a aidée, selon elle : "qu'on ne me demande pas de tout dire le premier jour", la stabilité du logement, et le fait d'avoir pu "remettre les années dans l'ordre" ; elle a construit avec moi une frise de sa vie, qu'elle garde chez elle.
Conclusion : fin du suivi régulier ce jour. Porte ouverte, RDV possible à sa demande, notamment autour des dates anniversaires (janvier).

Observation IDE du 20/01/2026 (Urgence : Bas)

Validé par PEYRUSSE Maryse - IDE le 20/01/2026 à 10:20
Renouvellement acamprosate et mirtazapine (ordonnance du Dr ARRIBAT). Patchs 14 mg maintenant, 8 à 10 cigarettes par jour.
Elle a passé le 19/01 "avec Mélanie et le petit", au cimetière de Bordeaux où elle a enfin retrouvé la tombe de Jeannot.
Pas de consommation. "C'est le premier janvier où je bois pas depuis 2021."
Rien d'autre à signaler.

Entretien téléphonique du 10/03/2026 (Urgence : Bas)

Validé par PEYRUSSE Maryse - IDE le 10/03/2026 à 16:05
Appel de Mme HOURQUEBIE : "je préfère vous le dire moi-même". Elle a bu samedi soir (07/03), pour ses 54 ans, à la pension de famille : "trois ou quatre verres de rosé", puis s'est arrêtée. Rien depuis. Pas de crack.
Pas de tremblements, pas de craving particulier ce jour, surtout "de la colère contre moi".
Rassurée : un écart n'est pas une rechute, on en reparlera avec le Dr ARRIBAT. Elle n'a pas pris l'acamprosate pendant le week-end, a repris ce matin.
RDV médical avancé au 14/04 comme prévu, pas plus tôt à sa demande.

Observation psychiatrique de suivi du 14/04/2026 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBAT Ségolène - Psychiatre addictologue le 14/04/2026 à 18:00

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Observations :
Vue ce jour.
Rappel : TUAL sévère depuis 2006 (premier sevrage en 2009), crack 2019-2021 et avril 2024, BZD de rue 2019-2021, TSPT, hépatopathie alcoolique, polyneuropathie. Abstinente depuis février 2025, en dehors d'un écart isolé le 07/03/2026 pour son anniversaire (3-4 verres), sans reprise.
Humeur stable depuis plus d'un an. Fin de la psychothérapie en novembre, pas de réapparition des cauchemars. Sommeil correct.
Elle demande à diminuer la mirtazapine, "je grossis" (64 kg, 49 kg en 2021).
Tabac : 8 cigarettes par jour, patch 14 mg.
Biologie : GGT 41, VGM 94, plaquettes 168.
Conclusions :
Mirtazapine 15 mg le soir, arrêt à envisager à l'automne si stabilité
Acamprosate 333 mg 2-2-2 poursuivi jusqu'à l'été au moins
Substituts nicotiniques
Certificat médical pour l'allègement de la mesure de protection
RDV 3 mois

Observation éducative du 23/06/2026 (Urgence : Bas)

Validé par GUIRAUD Mathieu - Éducateur spécialisé le 23/06/2026 à 15:30
Entretien éducatif.
Depuis début mai, Mme HOURQUEBIE est bénévole deux demi-journées par semaine à l'épicerie solidaire de Cenon : elle a commencé à la caisse, on lui a vite confié la tenue des stocks et le tableau des commandes, "comme chez Lamarque". Elle y prend plaisir, se lève à heure fixe.
Elle aimerait à terme un poste en chantier d'insertion sur de l'administratif, "à mi-temps, pas plus, avec mes pieds". Je prends contact avec deux structures pour la rentrée.
Familles : Teddy est venu à Cenon avec sa compagne en juin, "il a vu que j'avais un vrai chez-moi".
Pas de consommation, pas de passage au CAARUD depuis 2024. Elle a déposé un mot de remerciement pour Mme DUTHIL, que je transmettrai.

Observation psychiatrique de suivi du 13/10/2026 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBAT Ségolène - Psychiatre addictologue le 13/10/2026 à 18:30
Observations :
Vue ce jour.
Mme HOURQUEBIE, 54 ans, suivie au CSAPA depuis mai 2018.
Abstinente depuis le sevrage ambulatoire de février 2025, sans nouvel écart depuis celui du 07/03/2026. Pas de crack depuis mai 2024, pas de BZD depuis février 2024.
Acamprosate : souhaite l'arrêter, prise irrégulière depuis l'été, craving quasi absent. Accord pour l'arrêt.
Mirtazapine 15 mg : sommeil correct, humeur stable ; arrêt progressif proposé, elle préfère attendre "après janvier", ce que je comprends.
Tabac : 8 cigarettes par jour, patch 14 mg, souhaite tenter l'arrêt complet au printemps.
Fibroscan de septembre : 6,9 kPa. Neuropathie stable, marche sans aide.
Activité : bénévolat à l'épicerie solidaire, entretien prévu en novembre pour un chantier d'insertion (mi-temps, poste administratif). Requête en allègement de la curatelle déposée.
Famille : sa fille et son petit-fils réguliers, son fils deux fois par mois au téléphone.
Bilan de huit ans de suivi, repris avec elle : trois sevrages hospitaliers et un ambulatoire au CSAPA, une crise convulsive et un delirium, deux ans de rue, un deuil, puis un lent retour. Elle conclut : "j'ai remis ma vie dans l'ordre, pas tout, mais l'essentiel".
Conclusions :
Arrêt de l'acamprosate
Mirtazapine 15 mg, réévaluation en février
Substituts nicotiniques
Espacement des RDV : tous les 3 mois ; IDE à la demande